

16 - 03- Toxi-infection alimentaire collective - Pr. IHBIBANE

(0:01 - 0:40)

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur toxi-infection alimentaire collective. Les objectifs de notre cours sont définir une toxi-infection alimentaire collective, expliquer les mécanismes physiopathologiques des toxi-infections alimentaires collectives, prédire les germes responsables des toxi-infections alimentaires collectives en fonction des symptômes cliniques et prendre en charge une toxi-infection alimentaire collective. Une toxi-infection alimentaire collective est définie par l'apparition de moins de cas d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

(0:41 - 1:14)

C'est un problème de santé publique et ils sont considérés des maladies à déclaration obligatoire par téléphone puis par papier. Sur le plan physiopathologique et clinique, les germes qui sont responsables d'une toxi-infection alimentaire collective peuvent avoir une action invasive, ce qui va être responsable d'un syndrome dysentérique par colonisation ou ulcération. La teinte est essentiellement hyliocollique avec présence de glaire et du sang dans les selles, le patient et les fibrils.

(1:15 - 1:33)

D'autres germes peuvent avoir une action entérotoxigène, ce qui va être responsable d'un syndrome colérimforme. La sécrétion de l'otaxine va être responsable d'une stimulation des sécrétions. Pas de destruction cellulaire ou vilositaire.

(1:34 - 2:03)

Et concernant la multiplication bactérienne, soit qu'il est absente ou qu'il est minime, le patient est apéritique ou il peut présenter une fièvre modérée. Dans le cadre d'une toxi-infection alimentaire d'expression digestive prédominante, on va commencer par le syndrome de type invasif. L'incubation est de 12h à 36h.

(2:04 - 2:22)

Présence d'un syndrome fébrile franc avec une température supérieure à 38,5°C. Présence de troubles digestifs à type de vomissement, diarrhée, douleur abdominale, souvent dysentérie. Possibilité de localisation extra-digestif et qui font la gravité de la maladie.

(2:23 - 2:45)

Les agents responsables sont *Salmonella* nantifique dans 60% des cas, essentiellement *Salmonella enteritidis*. Rarement qu'un *pylobactère jejuni*, il veut *brío-para-hémolyticus*, *Shigella*

hiernitia. Le diagnostic positif, il est posé par la coproculture.

(2:47 - 3:05)

Le syndrome de type toxinique, peu ou pas de fièvre. La température est généralement inférieure à 38,5°C. On peut observer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et une diarrhée liquide profuse chez le patient.

(3:06 - 3:17)

Le risque est la déshydratation et le colapsus. L'évolution, il est rapidement favorable. Le diagnostic, il est fait sur l'anamnèse et la coproculture.

(3:17 - 3:42)

Il est peu ou pas d'intérêt diagnostique. Pour les agents pathogènes, il y a le *Staphylococcus aureus* dont l'incubation est de 1 à 6 heures. La contamination des aliments par porteur sain, essentiellement rhinopharyngée ou à partir d'une plaie infectée par le *Staphylococcus aureus* à partir d'un firacle ou d'un panary.

(3:43 - 4:08)

Il y aura une production d'entérotoxines thermostables au sein de l'alimentation. Les produits incriminés sont ceux ayant subi une manipulation importante, essentiellement les salades composées et les viandes séchées, et les produits laitiers tels le fromage, le lait et les crèmes glacées. Le *Clostridium perfringens*, c'est la deuxième cause après le *Staphylococcus aureus*.

(4:08 - 4:23)

L'incubation, il est de 8 à 24 heures. Les produits incriminés sont les plats cuisinés la veille, la restauration collective et la réfrigération insuffisante. Les viandes en sauce, c'est une cause fréquente de contamination.

(4:24 - 4:45)

Le *Bacillus cereus*, c'est la troisième cause des toxi-infections alimentaires collectives d'origine toxinique. L'incubation, il est de 1 à 6 heures quand les vomissements prédominent, 6 à 12 heures quand il s'agit de diarrhées. Les aliments contaminés sont le riz, la purée et les légumes germés tels le soja.

(4:46 - 5:31)

Rarement, l'*Echerichia coli* entero-hémorragique qui provoque des épidémies de diarrhées aqueuses et hémorragiques, l'*Echerichia coli* entero-toxinogène s'en transmet par l'eau et donne une diarrhée très liquide. En résumé, au cours d'une toxi-infection alimentaire collective, selon la

durée d'incubation, s'il est moins de 12 heures avec absence de fièvre, les germes incriminés c'est le *Staphylococcus aureus*, le *Bacillus cereus* et le *Glostridium perfringens*. Si la durée d'incubation est plus de 12 heures avec présence de fièvre, les germes incriminés sont *Salmonella*, *Yernicia*, *Campylobacter* et *Shigella*.

(5:34 - 5:47)

Passons maintenant aux toxi-infections alimentaires d'expression extra-digestive prédominante. Le Botulisme. L'agent pathogène, c'est le *Glostridium botulinum*.

(5:47 - 6:02)

C'est un bacille tellurique anérobistride qui sécrète une toxine thermolabile résistante au sucre digestif. On le retrouve dans les conserves domestiques, les viandes ou les poissons salés. La contamination est essentiellement digestive par inoculation.

(6:03 - 6:31)

Le mécanisme d'action, c'est par inhibition de la libération d'acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaires, ce qui bloque la transmission entre le nerf et le muscle avec risque de paralysie respiratoire et locomotrice. La toxine ne franchit pas la barrière hémocérébrale, donc pas d'atteinte du système nerveux central. Le tableau clinique est le même quel que soit le mode de contamination.

(6:31 - 6:51)

L'incubation est de 5 heures à 5 jours. Au cours de la période d'invasion, il y aura des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée chez le patient. Au cours de la période d'état, des atteintes oculaires sont possibles, telles la prise d'ICI aiguë, la diplopie et la midriase.

(6:53 - 7:21)

Des atteintes neurologiques, telles les paralysies descendantes bilatérales et symétriques, avec atteinte des paires crâniennes, des membres et des muscles respiratoires. Les autres atteintes sont le syndrome sec, la dysphagie, la dysphonie, les fausses routes, la dysurie ou la rétention d'urine, l'hypotension artérielle, les troubles du rythme cardiaque et la sténie. Et il faut dire qu'il n'y a pas de fièvre ni de syndrome mélingé.

(7:21 - 8:09)

La confirmation du botulisme est rapportée par la recherche de toxines et les anomalies retrouvées à l'électromyogramme. Pour la prise en charge du botulisme, il repose sur l'hospitalisation du patient et un traitement symptomatique qui est très important basé sur

l'hydratation, l'alimentation par entérale ou par sonde gastrique, la mise d'une sonde vésicale, un lavement évacuateur et la ventilation artificielle. Un traitement étiologique qui est basé sur la sérothérapie, l'anatoxine et l'antibiotique.

(8:13 - 8:31)

Pour l'intoxication histaminique, il survient après consommation de poissons mal conservés, surtout tonnes. L'incubation est de 10 minutes à 1 heure. Sur le plan clinique, on aura des troubles vasomoteurs, un érythème de la face et du cou, des céphalées et des signes digestifs.

(8:31 - 9:31)

La régression est rapide, accélérée par les corticoïdes et les antihistaminiques. Pour le diagnostic positif de toxi-infection alimentaire collectif, il est basé sur le regroupement de cas dans le temps et l'espace venant après un repas commun, la présence d'un symptôme pathologique clinique qui permet de suspecter l'agent infectieux responsable, la confirmation est basée sur l'examen microbiologique des sels, des vomissements et de l'aliment suspecté. Concernant la prise en charge, un traitement symptomatique basé sur l'équilibration hydroélectrolytique orale avec la prescription des sels de réhydratation oraux, du Coca-Cola, du jus de fruits ou par voie intraveineuse, la prescription de ralentisseurs du transit, tels l'opiramide, y sont contre-indiqués dans les diarrhées à germes invasifs.

(9:32 - 10:09)

La prescription des adsorbants, tels l'argile, du smectite, y ont une efficacité modérée. Le traitement spécifique est basé sur une antibiotérapie, dont les objectifs sont de diminuer l'intensité et la durée de la diarrhée, réduire le risque de diffusion bactériennique et réduire la contagiosité. Les indications, c'est en fonction de la présence des signes généraux, des signes d'invasion de la muqueuse digestif, diarrhées colériques sévères, tels le turista et le choléra, et en présence d'un terrain fragilisé.

(10:12 - 10:35)

Voici un tableau qui résume le traitement empirique des diarrhées aiguës. En présence de celles colériques avec une température inférieure à 38,5°C, dans les formes modérées, le traitement se base sur un traitement symptomatique. Si inefficacité, après 12 à 24 heures, il faut associer des fluoroquinolones ou l'azithromycine.

(10:35 - 11:03)

Dans les formes sévères, il faut prescrire les fluoroquinolones ou l'azithromycine plus le traitement symptomatique. Dans les diarrhées avec ou sans dysentérie, avec une température supérieure à 38,5°C, il faut prescrire des fluoroquinolones ou de l'azithromycine. Et un anti-péristaltique, il est contre-indiqué.

(11:05 - 11:28)

Voici un arbre décisionnel devant une toxi-infection alimentaire collective. En cas de diarrhées aiguës présumées bactériennes, il faut une évaluation clinique. En présence de signes de gravité selon le type de diarrhée, d'épidémiologie et s'il y a un terrain fragilisé, il faut faire des prélèvements pour études microbiologiques et une déclaration.

(11:29 - 12:05)

En présence de critères de gravité telles la déshydratation, un état de choc, la présence de douleur abdominale sévère, l'évolution depuis plus de trois jours et en présence d'un terrain fragilisé, il faut hospitaliser le patient avec une exploration selon le contexte. En présence de diarrhées, il faut un traitement symptomatique et un traitement antibiotique, plus ou moins un anti-diarrhéique. En absence de critères de gravité, on peut mettre le patient sous traitement symptomatique.

(12:06 - 12:33)

Après, une évaluation après 24 à 48 heures, soit qu'on aura une résolution du problème, soit persistance de la diarrhée. Et dans ce cas, ça rejoint l'indication d'hospitalisation pour l'exploration selon le contexte et un traitement symptomatique, un antibiotique et plus ou moins un anti-diarrhéique. Passons maintenant à la prophylaxie.

(12:35 - 13:04)

Cette prophylaxie est basée essentiellement sur le respect du nettoyage, c'est-à-dire une bonne hygiène corporelle et générale, nettoyer les ustensiles à l'eau chaude savonneuse avant de préparer les aliments et après, et nettoyer les surfaces avec un produit désinfectant ou un mélange d'eau de javel et de l'eau. La séparation. Séparer les aliments crus de la viande, volaille, les oeufs, le poisson et les fruits de mer ainsi que de leur jus.

(13:05 - 13:13)

Des plats préparés. Ne jamais placer un aliment cuit dans une assiette qui a contenu des aliments crus. La cuisson.

(13:14 - 13:29)

Il faut ramener la partie interne des aliments à la température voulue et vérifier l'état de cuisson à l'aide d'un thermomètre de cuisine. Faire cuire les oeufs jusqu'à ce que le jaune et le blanc soient fermes. La réfrigération.

(13:30 - 13:47)

Réfrigérer ou congeler les produits périssables, les plats préparés et les restes dans les deux heures et s'assurer que le réfrigérateur est réglé à moins de 4,5°C et que le compartiment congélateur est réglé à moins de 17,5°C.